

Valvulopatías (Mitral y Aórtica)

1. Introducción y relevancia clínica

Las **valvulopatías cardíacas** son alteraciones estructurales o funcionales de las válvulas cardíacas que producen **obstrucción al flujo (estenosis)** o **regurgitación (insuficiencia)**. Estas lesiones generan sobrecarga de presión o volumen en las cavidades cardíacas, conduciendo finalmente a **hipertrofia, dilatación e insuficiencia cardíaca**.

En Chile, la etiología ha cambiado significativamente: la **fiebre reumática**, antes predominante, ha disminuido gracias al acceso a antibióticos, mientras que las **valvulopatías degenerativas, calcificadas y funcionales** son ahora más frecuentes en adultos mayores.

Las válvulas más afectadas son la **mitral** y la **aórtica**, responsables de la mayoría de los cuadros clínicos relevantes en medicina interna y cardiología.

La detección precoz es esencial, ya que un manejo oportuno puede **prevenir insuficiencia cardíaca, muerte súbita o embolias sistémicas**.

En el **EUNACOM**, este tema es habitual en preguntas clínicas de auscultación, soplos, ecocardiografía y conducta terapéutica:

- Diferenciar **estenosis vs insuficiencia**.
 - Identificar el **tipo de soplo y su irradiación**.
 - Reconocer **indicación de cirugía valvular o manejo médico**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El corazón posee cuatro válvulas: mitral, tricúspide, aórtica y pulmonar. Las **válvulas mitral y aórtica**, del lado izquierdo, están sometidas a presiones más altas y, por tanto, son las más afectadas.

Las lesiones valvulares se clasifican en:

- **Estenosis:** dificultad para abrirse, genera sobrecarga de presión en la cavidad proximal.
- **Insuficiencia o regurgitación:** cierre incompleto, produce reflujo y sobrecarga de volumen.

En respuesta, el corazón desarrolla mecanismos adaptativos:

- **Hipertrofia concéntrica** en la estenosis (para vencer la presión).

- **Hipertrofia excéntrica y dilatación** en la insuficiencia (para compensar el volumen regurgitado).

Con el tiempo, estos mecanismos se vuelven maladaptativos, llevando a **disfunción miocárdica, insuficiencia cardíaca y arritmias**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Los síntomas dependen del tipo y severidad de la lesión valvular.

Los más comunes son **disnea de esfuerzo, fatiga, angina, síncope y palpitaciones**.

En fases avanzadas aparecen **edemas, ortopnea o disnea paroxística nocturna**.

VALVULOPATÍA MITRAL

3.1 Estenosis mitral (EM)

Etiología y fisiopatología

En el 90 % de los casos es de origen **reumático**, consecuencia de una carditis postestreptocócica.

Produce **engrosamiento, fusión de comisuras y retracción de valvas**, con reducción del área valvular mitral.

El área normal de la válvula mitral es de **4–6 cm²**; los síntomas aparecen cuando disminuye a **<2 cm²**, y son graves bajo **1 cm²**.

La obstrucción al flujo auriculoventricular izquierdo causa **aumento de presión en la aurícula izquierda, hipertensión pulmonar** y, finalmente, **insuficiencia cardíaca derecha**.

Manifestaciones clínicas

- **Disnea progresiva** (por aumento de presión en capilares pulmonares).
 - **Ortopnea y disnea paroxística nocturna**.
 - **Hemoptisis leve o palpitaciones** por fibrilación auricular secundaria.
 - En casos avanzados: **edemas, hepatomegalia, ascitis**.
-

Examen físico

- **Ritmo irregular** si hay FA.
- **Auscultación:**
 - **Soplo diastólico en roncus** (grave, de baja frecuencia), mejor audible en ápex con campana, en decúbito lateral izquierdo.
 - **Refuerzo presistólico** si hay ritmo sinusal.
 - **Chasquido de apertura mitral (snap)** tras el segundo ruido (cuanto más corto el intervalo S2–snap, más severa la estenosis).
 - **Pulso pequeño y aumento del primer ruido cardíaco (S1).**

Comentario EUNACOM:

El hallazgo clásico es *“mujer joven con disnea progresiva, soplo diastólico en ápex y chasquido de apertura”* → diagnóstico: estenosis mitral reumática.

Complicaciones

- **Fibrilación auricular** (por dilatación auricular izquierda).
 - **Embolias sistémicas.**
 - **Hemoptisis o edema pulmonar.**
 - **Insuficiencia cardíaca derecha crónica.**
-

Diagnóstico

El **ecocardiograma Doppler** confirma el diagnóstico, mide el **área valvular mitral** y estima la **presión pulmonar**.

El **ECG** muestra **FA o crecimiento auricular izquierdo**.

La **radiografía de tórax** puede mostrar **doble contorno auricular** y congestión pulmonar.

Tratamiento

- **Medidas generales:** restricción de sal, diuréticos, control de frecuencia si FA.
 - **Anticoagulación:** indicada si FA o trombos auriculares.
 - **Intervención:**
 - **Valvuloplastia mitral percutánea** es tratamiento de elección si la válvula es flexible y sin trombos.
 - **Reemplazo valvular** si hay calcificación severa o anatomía desfavorable.
-

3.2 Insuficiencia mitral (IM)

Etiología y fisiopatología

Ocurre cuando la válvula mitral no se cierra completamente durante la sístole, permitiendo el reflujo de sangre al atrio izquierdo.

Causas principales:

- **Degenerativa o mixomatosa** (prolapso mitral).
- **Isquémica o funcional** (por dilatación del anillo o disfunción de músculos papilares).
- **Reumática** (retracción valvular).
- **Endocarditis infecciosa o ruptura de cuerda tendínea.**

La sobrecarga de volumen produce **dilatación auricular y ventricular izquierda**, con eventual **insuficiencia cardíaca**.

Clínica

- **Disnea de esfuerzo, fatiga y palpitaciones.**
 - En fases agudas (rotura de papilar o endocarditis): **edema pulmonar súbito y shock.**
-

Auscultación

- **Soplo holosistólico de alta frecuencia**, audible en ápex y **irradiado a la axila izquierda.**
 - **S3 presente** si hay sobrecarga de volumen.
 - En prolapso mitral: **clic mesosistólico** seguido de soplo tardío.
-

Diagnóstico

El **ecocardiograma Doppler** determina la causa, grado y repercusión.

ECG: signos de crecimiento auricular y ventricular izquierdos.

Rx: cardiomegalia y congestión pulmonar.

Tratamiento

- **Medidas generales:** control de HTA, uso de diuréticos en congestión.
- **Fármacos:** IECA o ARA II para reducir postcarga.
- **Reparación o reemplazo valvular** en insuficiencia moderada-grave con síntomas o disfunción del VI (FEVI <60 % o diámetro telesistólico >40 mm).
- En prolapso mitral leve: solo control clínico periódico.

Comentario EUNACOM:

Un “soplo holosistólico irradiado a la axila” es diagnóstico de insuficiencia mitral hasta demostrar lo contrario.

VALVULOPATÍA AÓRTICA

3.3 Estenosis aórtica (EA)

Etiología y fisiopatología

Causa más frecuente en adultos mayores es la **calcificación degenerativa**.

En jóvenes, la etiología principal es la **válvula bicúspide congénita**.

El área valvular normal es de 3–4 cm²; los síntomas aparecen bajo 1,5 cm² y son graves cuando <1 cm².

La obstrucción provoca **sobrecarga de presión y hipertrofia concéntrica del VI**, que mantiene el gasto hasta que se descompensa.

Clínica clásica (triada de estenosis aórtica)

1. **Angina de esfuerzo.**
2. **Síncope de esfuerzo.**
3. **Disnea progresiva (insuficiencia cardíaca).**

La aparición de síntomas marca **mal pronóstico** (sobrevida media sin cirugía: 2–3 años en disnea, 5 años en angina).

Auscultación

- **Soplo sistólico eyectivo** de intensidad creciente y decreciente, mejor audible en **2° espacio intercostal derecho, irradiado al cuello (carótidas)**.
 - **R2 disminuido o ausente.**
 - **Pulso parvus et tardus** (débil y de ascenso lento).
-

Diagnóstico

- **ECG:** hipertrofia ventricular izquierda.
 - **Ecocardiograma:** confirma área valvular y gradiente de presión.
 - **Cateterismo cardíaco:** se reserva para planificación quirúrgica.
-

Tratamiento

- Asintomáticos: observación y ecocardiograma anual.
- Sintomáticos o con FEVI <50 %: **reemplazo valvular aórtico (RVA)**.
- En pacientes no quirúrgicos: **implante percutáneo (TAVI)**.
- Evitar vasodilatadores e hipotensores potentes.

Comentario EUNACOM:

Varón de 70 años con **soplo sistólico irradiado al cuello y angina de esfuerzo** → diagnóstico: estenosis aórtica severa.

3.4 Insuficiencia aórtica (IA)

Etiología y fisiopatología

Causas crónicas:

- **Degenerativa, reumática o bicuspidia.**

Causas agudas:

- **Endocarditis infecciosa, disección aórtica o trauma.**

El reflujo diastólico desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo genera **sobrecarga de volumen y presión**, llevando a **hipertrofia excéntrica** y dilatación del VI.

Clínica

- **Disnea y fatiga** progresivas.
 - En IA aguda: **edema pulmonar** o **shock cardiogénico**.
 - En IA crónica: **palpitaciones** y **sensación de latido precordial**.
-

Auscultación

- **Soplo diastólico aspirativo**, de alta frecuencia, audible en **borde externo izquierdo**, con paciente inclinado hacia adelante y espiración.
 - **Soplo de Austin Flint** (raro): diastólico en ápex por flujo retrógrado que vibra sobre la válvula mitral.
 - Pulso **“en martillo de agua”** (Corrigan): colapso rápido, visible en carótidas.
-

Diagnóstico

- **Ecocardiograma Doppler** confirma el grado de regurgitación y repercusión ventricular.
 - **ECG:** hipertrofia del VI.
 - **Radiografía:** cardiomegalia y dilatación aórtica.
-

Tratamiento

- **Médico:** vasodilatadores (IECA, nifedipino) para reducir postcarga en IA crónica moderada.
 - **Quirúrgico:** reemplazo valvular si:
 - IA severa sintomática.
 - FEVI ≤ 55 % o diámetro telesistólico > 50 mm.
 - En IA aguda, cirugía de urgencia.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Las principales complicaciones de las valvulopatías son:

- **Insuficiencia cardíaca congestiva.**
- **Fibrilación auricular** (particularmente en EM e IM).
- **Embolias sistémicas** (FA no anticoagulada).
- **Endocarditis infecciosa** sobre válvulas dañadas o protésicas.
- **Muerte súbita** (EA severa no tratada).

El pronóstico mejora significativamente con cirugía o intervención oportuna.

En general, los pacientes asintomáticos con buena función ventricular pueden mantenerse estables por años, pero el inicio de síntomas indica **mal pronóstico sin cirugía**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. **Soplo diastólico = patológico hasta demostrar lo contrario.**
2. **Soplo sistólico irradiado al cuello → estenosis aórtica.**
3. **Soplo holosistólico irradiado a axila → insuficiencia mitral.**
4. **Chasquido de apertura + soplo diastólico en ápex → estenosis mitral.**
5. **Triada de EA (angina, síncope, disnea)** indica necesidad de cirugía.
6. En EM con FA, **anticoagulación siempre**, incluso con INR meta 2–3.
7. **TAVI** es alternativa percutánea en EA severa en pacientes añosos o con alto riesgo quirúrgico.

Errores frecuentes:

- No solicitar ecocardiograma ante un soplo diastólico.
- Tratar FA en EM sin anticoagulación.
- Confundir soplo sistólico de EA con IM por irradiación diferente.
- Usar nitratos o diuréticos agresivos en EA severa sintomática (riesgo de colapso).
- Retrasar cirugía esperando síntomas en pacientes con FEVI disminuida.

Comentario EUNACOM:

Las preguntas suelen describir un soplo característico y pedir el **diagnóstico valvular o la indicación de cirugía**, así como el **manejo anticoagulante en valvulopatías reumáticas**.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **valvulopatías mitral y aórtica** son las más frecuentes y clínicamente relevantes.
2. **Estenosis mitral**: soplo diastólico con chasquido de apertura, causa reumática.
3. **Insuficiencia mitral**: soplo holosistólico irradiado a axila, causa degenerativa o funcional.
4. **Estenosis aórtica**: soplo sistólico eyectivo irradiado a cuello, triada clásica (angina, síncope, disnea).
5. **Insuficiencia aórtica**: soplo diastólico aspirativo, pulso en martillo de agua.
6. El **ecocardiograma** es el examen confirmatorio y orienta el manejo quirúrgico.
7. En EUNACOM, reconocer **el tipo y localización del soplo** es clave para diagnosticar la valvulopatía correcta.